

Kuidas mõõta teenuste osutamise taset kohalikus omavalitsuses?

Metoodika katsetamisest täiskasvanute sotsiaalhoolekandeline abi näitel



Veiko Sepp

Tartu Ülikool



Rivo Noorkõiv

OÜ Geomedia

Artikkel tutvustab Tartu Ülikooli ja OÜ Geomedia välja töötatud metoodikat kohalike omavalitsuste teenuste osutamise võimekuse taseme ja selle muutumise hindamiseks, mida testiti põhjalikumalt kolmes omavalitsuses.

Artiklis tutvustame metoodikat kohalike omavalitsuste teenuste osutamise võimekuse taseme ja selle muutumise hindamiseks (Sepp, Noorkõiv ja Veemaa 2018). Metoodikale toetuvate analüüside põhjal on riigil võimalik paremini sihistada valdkonnapoliitikat, kohalikud omavalitsused (KOV) saavad võrrelda avalike teenuste sooritusinformatsiooni teiste KOV üksustega. Seega on metoodika ja selle alusel korraldatavate uuringute tulemused sisendiks:

- kohalike teenuste osutamise võimekuse ja teenuste kvaliteedi võrdlemisel läbi aja, sh enne ja pärast haldusreformi;
- keskvalitsusele parema ülevaate andmiseks, millisel tasemel kohalikke teenuseid osutatakse, et kavandada vajalikke sekkumisi- või toetusmeetmeid elanikele paremate teenuste pakkumiseks ning suunata fookus teenuste taseme tõstmisele;
- ülevaate andmiseks elanikele nende kohalikus omavalitsuses pakutavate

teenuste tasemest võrdluses ajas ja teiste KOVidega;

- kohalikele omavalitsustele enda võrdlemiseks ajas ja teiste KOViga, et teada, mida tehakse hästi ning mis vajaks järelaitamist (motiveerida paremal tasemel teenuste pakkumist);
- arutelu tekkimiseks ühiskonnas, millisel tasemel peaksid kohalikud teenused kättesaadavad olema ilma konkreetsete kriteeriumite fikseerimiseta seaduse tasandil;
- tulevikus portaali loomiseks, kus eri sihtgrupid (elanikud, ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, teised huvitatud osalised) saaksid lihtsalt ja mugavalt ülevaate KOVides pakutavate kohalike teenuste tasemest.

Kohalik omavalitsus teenuse osutaja ja korraldajana

Kohaliku omavalitsuse olemus ja ülesanded

on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduses, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja valdkondlikes seadustes. Välja töötatud seiresüsteem taotleb kooskõla kohaliku omavalitsuse mõistega, nii nagu see on defineeritud KOKS § 2 lõikes 1, mille järgi on „omavalitsusüksuse – valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganitel õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi”. Seiremetoodika annab võimaluse hinnata KOVi eesmärgi teostamist avaliku teenuse mõiste kaudu. Seejuures lähtutakse avarast avaliku teenuse mõistest, mis hõlmab nii otseseid kui ka kaudseid teenuseid, sh ka nt poliitikakujundamise teenust (*Teenuste kaardistamise juhend 2017, Avalike teenuste...* 2015). Sellisena mõistetuna on teenus hüve või väärtuse loomise vorm (Hastings ja Saperstein 2014) ja väärtuse loomine sihtrühmale, mis võimaldab saavutada oodatud tulemusi (Teenuste mõistete töörihm 2016), seda elukõige tavalise inimese vaatepunktist (Cole ja Parston 2006), kes saab loodud hüvedest kasu erinevates rollides: kodanikuna, kohuslasena, kasusaajana, abisaajana ja kliendina (Uus, Tatar ja Vinni 2014, Boivard ja Löffler 2009). Kuivõrd kohaliku omavalitsuse ülesannete hulk Eestis on väga ulatuslik, siis seiresüsteemi hõlmataivate ülesannete ringi mõnevõrra piiritleti ja ülesanded rühmitati 16 tegevusvaldkonda¹, millest sotsiaalvaldkonda kuulusid kolm: täiskasvanute sotsiaalhoolekandeline abi, lastekaitse ning rahvatervis ja turvalisus.

Teenuste hindamise kriteeriumid ja nende lävendid

Teenuste kirjeldamise, mõõtmise ja hindamise üldistes käsitlustes eristatakse teenuse osutamise sisendeid, protsesse, väljundeid, tulemusi ja mõjusid (Pidd 2012) ning samuti varasid ja ressursse, mis on teenuse osutamiseks kasutada (Esfahani 2005, 497–525). Arvestades ühelt poolt võrdleva mõõtmise prioriteetseid aspekte ning teiselt poolt teiste riikide kogemusi ja teenuste hindamise teoreetilisi käsitlusi, eristati teenusvaldkondade hindamisel kolme dimensiooni, millest kaks esimest jagunevad omakorda kaheks alamdimensiooniks. Esiteks, teenusvaldkonna korraldamise ja osutamise võimekus ehk ressursssidest tulenevad eeldused teenuseid korraldada ja osutada, mille all eristatakse: a) strateegilist, regulatiivset ja organisatoorset valmisolekut ja võimekust ja b) inimvarast ja taristust tulenevat valmisolekut ja võimekust. Teiseks, teenusvaldkonna korraldamise ja osutamise tase (vastab ligikaudu mõistele sooritus/*performance*), mille all eristatakse: a) teenuse kättesaadavust ja b) teenuste osutamise ja korraldamise protsessi kvaliteeti. Ning kolmandaks, teenusvaldkonna korraldamise ja osutamise tulemuslikkus.

Igale kriteeriumile määratleti kriteeriumi enda olemuslikust sisust lähtuv tase: kriteerium kas teenuse baastaseme, edasijõudnu taseme või eeskujuliku taseme hindamiseks. Üldpõhimõttena määratleti kriteerium baastaseme kriteeriumina siis, kui kriteeriumi seadmise aluseks on seadusest tulenev nõue, aga samuti muudel juhtudel, kus on olemas selge kriitiline tase, millest alates

¹ Üldjuhtimine, strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine, ehitustegevuse korraldamine, elamu- ja soojamajandus, liikuvus, liikluskorraldus ja teehoid, jäätmehooldus, veemajandus, alusharidus ja lastehoid, põhiharidus, noorsootöö, täiskasvanute sotsiaalhoolekandeline abi, lastekaitse, rahvatervis ja turvalisus, rahvakultuur ja kultuurielu, raamatukogundus, muuseumid, sport ja liikumisharrastus.

on põhjendatud arvata, et teenusvaldkonna korraldamisel või osutamisel KOVis esineb tõsisemaid probleeme. Edasijõudnu taseme kriteeriumid sobivad nende teenuse korraldamise ja osutamise aspektide hindamiseks, mis ei ole kriitilise tähtsusega kasusaajate heaolule, kuid mida igalt KOVilt üldjuhul oodatakse. Eeskujuliku taseme kriteeriumitega hinnatakse aga näiteks uuenduslike lahenduste rakendamist, täiendava võimekuse ja võimaluste kasutamist elanikkonna

hüvede suurendamisel.

Hindamissüsteemi osaks on ka teenusvaldkondade üldhinnangu andmine 9astmelisel skaalal ning selle andmise reeglistik. Viimane võtab aluseks üksikute kriteeriumite (vt tabel 1) ja nende lävendite täitmise osakaalud, millest lähtudes antakse igale KOVile konkreetses teenusvaldkonnas üldhinnang alljärgnevas tabelis esitatud tingimuste põhjal.

Kokku sisaldab metoodika 334

Tabel 1. Üldhinnang teenusvaldkondadele 9astmelisel skaalal

Tase			Hinnangu kvantitatiivne tingimus
1	2	3	
9	A+	supereeskujulik tase	kõik kriteeriumid on täidetud maksimaalsel võimalikul tasemel, kuid lubatud on ühe eeskujuliku taseme lävendi mittetäitmine
8	A	tugev eeskujulik tase	kõik baastaseme ja edasijõudnu taseme lävendid on täidetud, lisaks vähemalt 2/3 eeskujuliku taseme lävenditest
7	A-	puudustega eeskujulik tase	kõik baastaseme ja edasijõudnu taseme lävendid on täidetud, lisaks vähemalt 1/3 eeskujuliku taseme lävenditest
6	B+	tugev edasijõudnu tase	kõik baastaseme ja edasijõudnu taseme lävendid on täidetud
5	B	puudustega edasijõudnu tase	kõik baastaseme lävendid on täidetud, lisaks vähemalt 2/3 edasijõudnu taseme lävenditest
4	B-	nõrk edasijõudnu tase	kõik baastaseme lävendid on täidetud, lisaks vähemalt 1/3 edasijõudnu taseme lävenditest
3	C+	tugev baastase	a) kõik baastaseme lävendid on täidetud või b) mitte rohkem kui 1 baastaseme lävend on täitmata ning vähemalt 1/2 edasijõudnu taseme tingimustest on täidetud
2	C-	puudustega baastase	kuni 1/3 baastaseme lävenditest võib olla täitmata
1	D	ei vasta baastasemele	üle 1/3 baastaseme lävenditest ei ole täidetud

hindamiskriteeriumit (üldjuhul valdkonnas 15–25) ja edasiseks väljaarendamiseks veel 143 soovituslikku kriteeriumi. Käsitlemata detailselt hindamiskriteeriume teenusvaldkondade kaupa, ütleme vaid, et eesmärk oli anda kriteeriumite süsteemiga teenusvaldkondadele võimalikult terviklik ja tasakaalustatud hinnang. Samas on selge, et seiresüsteemi lõpliku toimimise mõttes seab kriteeriumite valikule piiranguid (ökonoomsete) mõõtmisvõimaluste olemasolu, mis ajas muutub.

Kriteeriumid täiskasvanute sotsiaalhoolekandelse abi valdkonnas

Täiskasvanute sotsiaalhoolekandelse abi valdkonna kriteeriumid määratleti metoodika koostajate ja laiapõhjalise valdkondliku töörühma töö ning kolme KOV üksuse (Tartu linna, Rae valla ja Räpina valla)

testimise tulemustele tuginedes. Töörühma oli kaasatud sotsiaalministeeriumi, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Pärnu linna esindajad. Konsulteriti ka sotsiaalkindlustusameti ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse spetsialistidega.

Täiskasvanute sotsiaalhoolekandelse abi valdkonnas on määratud 26 kriteeriumi kokku 53 lätendiga. Lisaks on tehtud ettepanek kaaluda veel 16 kriteeriumi mõõtmist ja hindamist. Seega taotletakse metoodika raames täiskasvanute sotsiaalhoolekande valdkonnas KOV üksuste tegevuse hindamist teenusvaldkondade võrdluses keskmisest ulatuslikumana, mille üheks põhjuseks on kahtlemata valdkonna enda olulisus ja mitmekülsus (nt lastekaitstes määratletakse 22 kriteeriumi). Kriteeriumite rühmade kaupa on valdkonna hindamiskriteeriumid alljärgnevad.

Hindamiskriteeriumid täiskasvanute sotsiaalhoolekande valdkonnas

1. Strateegilise, regulatiivse ja organisatoorse valmisoleku ja võimekuse kriteeriumid

- Sotsiaalhoolekandelse abi (teenused ja toetused) juhtimiseks on loodud strateegiline alus
- Sotsiaalhoolekandelse abi andmiseks on loodud KOV eripära arvestav õiguslik regulatiivne alus
- Sotsiaalteenuseid osutavate asutuste sisekord on õiguslikult reguleeritud
- Sotsiaalhoolekandelse abi küsimuste laiapõhjaliseks ja kaasavaks korraldamiseks on loodud organisatoorsed eeldused
- Riiklike ja rahvusvaheliste ressursside kaasamisega on loodud täiendav võimekus täiskasvanute sotsiaalhoolekandelse abi ülesannete täitmiseks
- Erasektori ja kodanikeühenduste kaasamisega on saavutatud täiendav võimekus täiskasvanute sotsiaalhoolekandelse abi arendamiseks ja osutamiseks
- *Eakate probleemide ja väljakutsetega tegelemiseks on loodud kohalik laia kandepinnaga esindusorganisatsioon (soovituslik kriteerium).*

2. Inimvarast ja taristust tuleneva valmisoleku ja võimekuse kriteeriumid

- Täiskasvanute sotsiaalhoolekandeline abi osutamist korraldavad kvalifitseeritud KOV teenistujad
- Üldhooldekodudes osutavad teenuseid kvalifitseeritud hooldustöötajad
- Sotsiaalhoolekandeline abi korraldavate ja osutavate teenistujate tööd väärtustatakse
- Üldhooldekodu hooldatavaid teenindab piisav arv hooldustöötajaid ja abihoolustöötajaid
- Koduteenuse avahoolekande hooldustöötajate arv on piisav
- Sotsiaalhoolekande teenuseid osutatakse heas seisundis hoonetes
- *Hooldajate tööd väärtustatakse (soovituslik kriteerium)*
- *Üldhooldekodude töö kvaliteeti suurendavad kaasatud vabatahtlikud (soovituslik kriteerium).*

3. Teenuste kättesaadavuse kriteeriumid

- Abivajajatele on tagatud lai valik täiskasvanute sotsiaalhoolekandeline abi teenuseid
- Erinevatele täiskasvanute sotsiaalhoolekandeline abi sihtrühmadele on tagatud toetuste saamise võimalused
- Üldhooldekodu teenus on kodulähedane
- Päevakeskuse teenus on kodulähedane
- *Tagatud on erivajadustega inimestele füüsilise juurdepääs sotsiaalhoolekande munitsipaalasutustele (soovituslik kriteerium).*

4. Teenuste korraldamise ja osutamise kvaliteedi kriteeriumid

- Päevakeskustes pakutakse laia tegevuste valikut
- Üldhooldekodud pakuvad intervallhooldust ja päevahoiuteenuseid
- Üldhooldusteenuse raames on tagatud tugispetsialistide ja/või -teenuste pakkumine
- Täiskasvanute sotsiaalhoolekande teenuste ja toetuste teave on elanikele kättesaadav
- Toimub ajakohase teabe süsteemne kogumine ja analüüs sotsiaalhoolekandeline abi kohta
- Sotsiaalhoolekandeline abi osutamise osaks on elanikkonna teavitamine ja nõustamine meedias
- Sotsiaalhoolekandeline abi asutused omavad tagasisidemehhanisme
- *KOV sotsiaalhoolekande juhtumikorraldus on sidusus riigiteenustega (soovituslik kriteerium)*
- *Teenusele pöördujate puhul viiakse üldjuhul läbi sotsiaalhoolekandeline abivajaduse hindamine (soovituslik kriteerium)*
- *Vajadusel viiakse läbi juhtumivõrgustiku koosolekuid/ümarlaudu (soovituslik kriteerium)*

- Üldhooldusteenusele suunatavate hooldatavatele koostatakse hooldusplaan, mida uuendatakse vajadusel regulaarselt (soovituslik kriteerium)
- Koduteenuse kasutajatele koostatakse kõrvalise abi vajaduste hindamisakt ja hooldusplaan, mida uuendatakse vajadusel regulaarselt (soovituslik kriteerium)
- Sotsiaalteenuste osutamiseks on koostatud kohalikke vajadusi arvestavad teenusstandardid, mille alusel teenuseid osutatakse (soovituslik kriteerium)
- KOV sotsiaalteenuste ja -toetuste ning muu abi osutamise, juhtumikorralduse põhimõttel tehtava sotsiaaltöö toimingud menetletakse ja dokumenteeritakse registripõhiselt, registriandmeid kasutakse teenusvajaduse hindamisel ja prognoosimisel (soovituslik kriteerium)
- Koduteenuse osutamisel kasutatakse e-teenuste lahendusi (soovituslik kriteerium)
- Hoolekandeteenust pakkuvates munitsipaalasutustes ja ettevõtetes rakendatakse kvaliteedijuhtimise süsteeme (soovituslik kriteerium).

5. Teenuste korraldamise ja osutamise tulemuslikkuse kriteeriumid

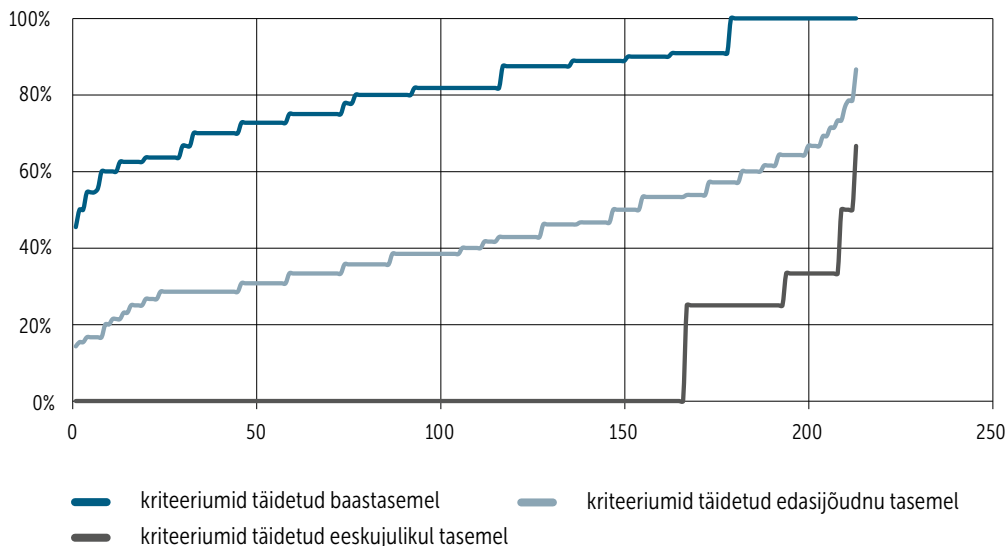
- Enamus hooldusvajadusega klientidest kasutab iseseisvat toimetulekut toetavaid hoolekandeteenuseid
- Toimetulekutoetuse saajate osakaal elanikkonnas on väike
- Sotsiaalhoolekandelise abi kliendid on rahul hoolekandeteenustest saadud kasuga (soovituslik kriteerium)
- Suur osa sotsiaalhoolekandeteenuste tööelistest klientidest on tööga hõivatud (soovituslik kriteerium)
- Omastehooldajatel on võimalus käia tööl (soovituslik kriteerium).

Testmõõtmiste tulemused

Valdkonna testmõõtmised viidi läbi 2016. aasta seisuga ehk haldusreformielsete KOV üksuste kohta. Kättesaadavatele üleriigilistele andmetele tuginedes mõõdeti kõiki 213 KOV üksust ning lisaks kolme testitud KOV üksust kõigi avalike andmete alusel (nt KOV dokumendiregistrid ja veebilehed), andmeid täiendati testimise raames läbi viidud intervjuude tulemustega. Kokku õnnestus kõigi 213 üksuse kohta mõõta kriteeriumite 11 baastaset (79% kõigist kriteeriumite baastasemetest), 15 edasijõudnu taset (63%) ning 4 eeskujulikku taset (27%). Testüksuste teenuste taset oli võimalik mõõta terviklikult (metoodiliselt oli mõõtmisvõimaluste olemasolu kriteeriumite valiku ja soovituslike kriteeriumite

väljaarvamise aluseks): mõõdeti 14 baastaset, 24 edasijõudnu taset ning 15 eeskujulikku taset.

Testmõõtmisel kasutatud andmete ebaühtlase kvaliteedi ning koondhinnangu arvutamise reeglستiku ranguse tõttu (vt eespool kirjeldatud kriteeriumeid ja lävendeid) on esialgseks mõõtmistulemuseks see, et 29 ehk 14% haldusreformi eelset KOV üksust ei täitnud täiskasvanute sotsiaalhoolekande ülesandeid baastasemel. Baastaset täitnud üksustest piirdus enamik (123 üksust ehk 57%) teenuste osutamisega puudulikul baastasemel ehk siis mitte kõik kriteeriumid ei olnud neil baastasemel täidetud. Kokku 30 KOV üksust (14%) saavutas edasijõudnu taseme – 25 nõrga edasijõudnu (tase 4) ja 5 puudustega edasijõudnu taseme (tase 5).



Joonis 1. Kriteeriumite lävendeid täitvate kohaliku omavalitsuse üksuste osakaal

Vaadates mõõtmistulemusi sõltumatult koondhinnangu arvutamise valemist, ilmneb, et ühe erandiga täitsid kõik KOV üksused vähemalt 50% baastaseme lävenditest ning valdav osa KOVe (181 ehk 85%) täitis vähemalt 70% baastaseme lävenditest. Edasijõudnud taseme lävendeid täitnud KOVe oli läbivalt 30–35% võrra vähem, samas kui eeskujuliku taseme lävendeid täitis üldse ainult 47 KOVi (22%) ning sedagi 25% ulatuses (4st mõõdetud ja asjakohasest lävendist), vt joonis 1.

Kõik kolm testitud KOVi saavutasid oluliselt täielikumate mõõtmiste alusel arvutatud koondhinnangutes vähemalt baastaseme – kaks neist puuduliku baastaseme

(ehk hinde kaks üheksapallisel skaalal) ning üks baastaseme ilma reservatsioonideta (hinne kolm). Baastaseme lävendeid täideti nendes üksustes 69–93% ulatuses, edasijõudnu taseme lävendeid 46–67% ning eeskujuliku taseme lävendeid 20–21% ulatuses.

Kolme KOV üksuse testimine näitas ka seda, et paljude üleriigiliselt praegu veel mittemõõdetavate kriteeriumite usaldusväärseks ja tõendatud mõõtmiseks vajalik teave ja teadmine on kohalikul tasandil olemas. Küsimus on, kuidas see teadmine muuta ühtse metoodika alusel faktiandmeteks ning seejärel mõõtmisteks sobivana süsteemselt ja kestlikult kokku koguda. Olulise osa töö

² Fakti- ja tõendus põhist enesehindamist ehk enesemõõtmist tuleb eristada enesehindamisest, mille tulemusena antakse subjektiivseid või kokkuleppelisi (intersubjektiivseid) üldhinnanguid olukorra või protsesside toimimise kohta (hea, väga hea, halb jne). Selleks et vältida ootustest lähtuvaid mõõtmisvigu usaldusväärsuse mõttes, soovitatatakse koostatud metoodikas opereerida üksnes enesemõõtmise tulemustega või siis luua üldhinnangute andmise aluseks faktiliste tingimuste loend, mida tuleb hinnangu andmiseks täita (nt hoonete seisukorra hinnangud peavad põhinema teatud loendi tingimuste täitmisele või mittetäitmisele).

raames esitatud metoodika arendamise ettepanekute sisuks on laiendada sel eesmärgil kohaliku tasandi (linna- ja vallavalitsuste, teenuseid osutavate asutuste ja ettevõtete) fakti- ja tõenduspõhist enesehindamist (olemuslikult enesemõõtmist)² metoodika vajadustest lähtudes. Andmekorje ja mõõtmiste jätkusuutlikkuse tagamiseks on seejuures soovitatav nende mõõtmiste andmeobjektide ja tulemuste (väärtuste) lõimimine juba olemasolevatesse andmekogudesse, mille sisu on valdavalt samuti erinevate enesemõõtmiste tulemusena kujunenud.

Kokkuvõtteks

Seiremetoodika katsetamise käigus hinnati tagasisaatavalt haldusreformielsest olukorda Eesti KOVIDes 2016. aastal, tuginedes üleriigiliste registrite ning muude ametlike ja mitteametlike andmekogude andmetele. Testimine näitas, et praegu pole teenusvaldkondade tasakaalustatud ja terviklikuks hindamiseks Eestis piisavalt n-ö valmis andmeid. Kõige paremad, kuid kaugeltki mitte täielikud ja probleemivabad mõõtmisvõimalused on inimvara ning tulemuslikkuse dimensioonidel. Samas on nimelt KOVi tegevuse tulemuslikkuse hindamine teoreetiliselt kõige problemaatilisem, kuivõrd üldjuhul on KOVi sekkumine teenusvaldkonda üksnes osaline ja riigi tasandil õiguslikult piiratud; tulemused ühes või teises teenusvaldkonnas sõltuvad tugevalt piirkondade üldisemast sotsiaalmajandusliku arengu tasemest. Teistel olulistel hindamisdimensionidel, kus omavalitsusorganite tegevus või tegevusetus ilmneb oluliselt selgemalt, leidub koheste üleriigiliste usaldusväärsete mõõtmisvõimalustega kriteeriume vähe. Sageli on vaja olemasolevaid andmeid käsitsi töödelda (koondada, sisu metoodiliselt liigitada, teiste andmekogude andmetega ühendada jms) või siis erinevate metoodikate abil

täiendavalt toota. See ei tähenda aga seda, et metoodikat ei oleks võimalik ega vajalik täiendavate kriteeriumite ja vastavate mõõtmiste arvelt edasi arendada.

Tulenevalt STARi andmete ebatäielikkusest ja -ühtlusest KOV üksuste kaupa, ei saa neid hetkel ja tagasisaatavalt 2016. aasta kohta mõõtmiseks veel kasutada. Seetõttu tehti oluline osa sotsiaalhoolekande kriteeriumite mõõtmistest tuginedes S-Veebi ja H-Veebi aruannetele. Koondaruannete alusel teostatavate mõõtmiste peamine probleem seisneb selles, et mitmete oluliste sotsiaalteenuste kohta on andmed kogutud ja esitatud üksnes teenuseid osutavate asutuste kohta H-veebis. Need andmed sobivad KOV üksuste hindamiseks niivõrd, kui hindavad vastavate munitsipaalasutuste juhtimist ja ressurssidega varustatust. Asutusepõhiste andmete alusel puudub aga võimalus hinnata seda, kuivõrd ja kuidas on ühe või teise KOV üksuse elanike teenusevajadus rahuldatud, mis võib toimuda erinevates üldhooldekodudes, turvakodudes, asenduskodudes jne (mis pealegi võivad olla nii munitsipaalomandis kui ka riigi või eraomandis). See saab toimuda üksnes isikupõhiste andmete alusel, mis on seostatud asutusepõhiste andmetega (H-veebis või STAR teenuseosutajate kohta kogutavate andmete nimekirja laiendamisel). Lootust selleks pakub tõsiasi, et alates registri loomisest 2012. aastal on STAR andmete kvaliteet aasta-aastalt paranenud ning alates aastast 2021 on kohustuslik STARi märkida kõik pöördumised ja menetlustoimingud. Oluliseks sisuliseks väljakutseks STARis on teenusvajaduse adekvaatne määramine sõltumatult inimesele osutatavatest teenustest, mis on eelduseks teenusvajaduse rahuldatuse hindamisel.

Samal ajal vajab lahendust ka registriandmete operatiivse ja ökonoomse

kättesaadavuse küsimus. Testimine näitas, et mitmete registrite andmete väljastamine metoodika raames mõõtmiste teostamiseks nõuab registrite ebapiisava tehnilise taseme tõttu registritöötajatelt kuni mitmenädalalist „käsitsi” tööd, kuna registrite arendustööd on pooleli. Need tuleb lõpule viia.

Laiemas vaates toetaks metoodika raames teostatavate mõõtmiste ökonoomsust see, kui andmevaldajad hakkaksid täitma avaliku teabe seadusega sätestatud kohustust muuta võimalikult suur osa kogutavatest registriandmetest töödeldaval kujul avalikult kättesaadavaks. **S**

Artikkel kajastab uurimust „Kohalike avalike teenuste tasemete seire metoodika väljatöötamine ja testimine ning analüüsi läbiviimine”, mille tellijad on rahandusministeerium ja Riigikantselei strateegiabüroo ning täitja Tartu Ülikool ja OÜ Geomedia. Töö autorid tänavad kõiki, kes andsid töö valmimisse panuse.

Viidatud allikad

- Avalike teenuste korraldamise roheline raamat** (2015). Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. www.mkm.ee/sites/default/files/avalike_teenuste_korraldamise_roheline_raamat.pdf. (10.12.2018).
- Boivard, T., Löffler, E.** (toim). (2009). Public Management and Governance, 2nd edition. Routledge, Oxon.
- Cole, M., Parston, J.** (2006). Unlocking public value: a new model for achieving high performance in public service organizations. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
- Esfahani, H. S.** (2005). Alternative public service delivery mechanisms in Iran. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, Volume 45, 497–525.
- Hastings, J., Saperstein, H.** (2014). Service thinking: the seven principles to discover innovative opportunities. Business Expert Press.
- Pidd, M.** (2012). Measuring the Performance of Public Services. Cambridge University Press, New York.
- Sepp, V., Noorkõiv, R., Veemaa, J.** (2018). Kohalike avalike teenuste tasemete seire metoodika väljatöötamine ja testimine ning analüüsi läbiviimine. Tartu Ülikool ja OÜ Geomedia.
- Teenuste kaardistamise juhend.** (2017). Teoses: Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine. www.rahandusministeerium.ee/et/teenuste-kaardistamise-juhend. (10.12.2018).
- Teenuste mõistete töörihm.** (2016). Eesti avalike teenuste ja IKT teenuste osutamise seotud mõistete mudel.
- Uus, M., Tatar, M., Vinni, R.** (2014). Avalike teenuste delegeerimine vabahendustele. Praxis, Tallinn.